

URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN ORL

Ignacio Alvarez Alvarez.

EPISTAXIS

La epistaxis es un problema frecuente, generalmente sin gravedad, ya que en los niños habitualmente la causa es local, y muy excepcionalmente constituye un síntoma de enfermedad sistémica.

La mayoría de las veces la ocasiona una inflamación local, infecciosa o alérgica y/o un microtraumatismo autoproducido por rascado o manipulación. Sin embargo, debe tenerse siempre en consideración, sobre todo en las repetidas, la posibilidad de que la epistaxis sea una manifestación de alguna enfermedad más grave: hipertensión arterial, discrasia sanguínea, hepatopatía, tumor.

La exploración es sencilla: una rinoscopia anterior nos mostrará, en la mayoría de las ocasiones, un punto hemorrágico en el área septal inferior. En estos casos la mejor opción es una **cauterización química** con una **barrita de Nitrato de Plata**. Si el punto sangrante no es visible podemos intentar controlarlo comprimiendo las alas nasales, introduciendo una bola de algodón con agua oxigenada o una esponja hemostática (Merocel y similares). Solo en casos excepcionales tendremos que recurrir a un neumotaponamiento con sonda de doble balón, a un taponamiento posterior clásico, a una embolización o a una cirugía de urgencia, pero todas esas opciones deben estar disponibles antes de que el sangrado comprometa hemodinámicamente al paciente. En estos casos la estabilización de las constantes, el control de factores favorecedores del sangrado y la evaluación conjunta con el especialista correspondiente son obligados.

CUERPOS EXTRAÑOS

Ante la sospecha de un cuerpo extraño en cualquier localización ORL se debe impedir la ingesta de alimentos o líquidos hasta conseguir la extracción, por si fuera necesaria una exploración quirúrgica. A continuación evaluar el sitio donde está alojado para saber si será necesaria una extracción bajo sedación o anestesia, teniendo siempre preparado el instrumental necesario para la extracción en esa primera exploración. La exploración en la consulta debe hacerse en posición sentada, nunca en decúbito; en los niños pequeños recurriremos a los padres o algún ayudante para mantenerlos sentados en la posición más erguida posible.

CUERPOS EXTRAÑOS EN EL OÍDO

Habitualmente la introducción ocurre durante el juego y no es excepcional que haya en ambos oídos o en oído y nariz, por lo que la exploración ha de ser completa. Suele tratarse de objetos inertes de cualquier composición. Los más **peligrosos** son las **pilas de botón**, por el riesgo de quemadura química. En el caso de que se trate de un insecto, la primera actuación ha de ser inmovilizarlo instilando alcohol en el conducto.

Generalmente es un adulto quien ha observado al niño introducirse el cuerpo extraño, pero otras veces es el propio niño el que lo dice; a veces es un hallazgo casual en una otoscopia por otro motivo y con poca frecuencia son los signos inflamatorios (dolor, edema, otorrea) los que nos llevan al diagnóstico.

Haremos una otoscopia teniendo a mano el instrumental necesario: aspirador de conducto, asa fría, ganchito, pinzas. La extracción con pinzas debe reservarse para alguien experimentado ya que de no conseguir atrapar el objeto en el primer intento, este migrará a una posición más distal

pudiendo lesionar el tímpano e impidiendo ya la evacuación sin anestesia.

Completada la extracción reexplorar el oído para comprobar el estado del mismo y la posible existencia de heridas, lesiones timpánicas o infección, y en su caso prescribir el tratamiento oportuno o remitir al especialista.

NASALES

Introducción

También aquí suele haber sido observado por algún adulto, pero no es excepcional el diagnóstico por un cuadro de rinorrea fétida y congestión nasal uni o bilateral. Cuerpos extraños no detectados pueden ser diagnosticados años después, generalmente en la edad adulta, como rinolitos debido a la precipitación de sales de Ca^{2+} . Una vez más las pilas de botón son las más problemáticas porque el ambiente húmedo hace que se degrade la carcasa metálica con extravasación de ácidos altamente tóxicos y abrasivos.

Diagnóstico

El diagnóstico suele ser sencillo.

- Por rinoscopia anterior o endoscopia nasal.
- Radiografía. Para objetos metálicos puede ser útil la radiología simple y solo en casos de alta sospecha sin visualización segura podría optarse por una TAC y/o una exploración endoscópica bajo sedación o anestesia.

Tratamiento

Una vez localizado el objeto se elegirá el instrumental en función de las características del mismo:

- aspirador.
- asa de alambre.
- ganchito de oído o pinzas que serán la última opción, y solo para personal entrenado, por el riesgo de introducir más e incluso desplazarlo a la rinofaringe con riesgo de broncospiración. Debemos, además descartar la presencia de algún otro objeto uni o contralateral o en los oídos, y si hay ya signos infecciosos prescribir un tratamiento antibiótico oral o tópico intranasal.

CUERPO EXTRAÑO EN LA VIA AERODIGESTIVA

La forma del objeto ingerido es determinante para el sitio de impactación

Así, cuerpos punzantes y ligeros como espinas de pescado o esquivras afiladas suelen enclavarse en las paredes faríngeas, casi siempre a nivel de las amígdalas o la base de la lengua, mientras que objetos más pesados o de contorno liso suelen alojarse en la vía aérea. Los punzantes tienen el riesgo de perforar la mucosa e incluso migrar a planos profundos con el riesgo de graves complicaciones infecciosas o vasculares.

La anamnesis no siempre es esclarecedora, sobre todo en los niños pequeños, porque el adulto que lo haya presenciado lo contará como que el niño “se ha tragado” algo. Es muy importante preguntar si ha habido en algún momento tos, disnea o disfonía, que nos orientarán hacia la laringe o la vía aérea inferior, mientras que la disfagia e hipersalivación harán más probable una impactación hipofaríngea o esofágica. La naturaleza del cuerpo extraño también es determinante en cuanto a maniobras diagnósticas y posibilidad de complicaciones. Los vegetales, como legumbres semillas, etc tienen una especial gravedad y deben ser manejados con la máxima prioridad porque por su contorno liso suelen migrar hasta la vía aérea, y por su tendencia a

hidratarse aumentando de tamaño, y la intensa reacción inflamatoria que provocan pueden desencadenar en poco tiempo complicaciones obstructivas graves. Aquí son mejor tolerados los inertes como monedas, bolas de plástico, etc, que pueden ser, además, localizados por radiología simple.

Un cuerpo extraño no sospechado puede estar en el origen de neumonías o abscesos de repetición en el cuello o el tórax o, incluso, simular un cuadro de asma o bronquitis de repetición.

Para el diagnóstico es decisiva la edad y grado de madurez del niño: salvo para cuerpos extraños en la orofaringe, que pueden ser vistos y extraídos en la consulta, en los niños más pequeños, o en aquellos que a cualquier edad no colaboren para la exploración, puede ser necesaria la radiología simple o la TAC y una exploración endoscópica flexible o rígida (rinofibrolaringoscopia, esofagoscopia, broncoscopia) o directa (faringo-larngo-esofagoscopia directas) bajo sedación o anestesia general, lo que, en el caso de impactación en la vía aérea superior, puede requerir la realización de una traqueotomía.

COMPLICACIONES DE LAS INFECCIONES ORL MÁS FRECUENTES EN NIÑOS

COMPLICACIONES DE RINOSINUSITIS

Poco frecuentes, pero potencialmente graves porque comprometen al ojo y/o al SNC.

Para su diagnóstico son importantes la anamnesis, buscando antecedentes de rinosinusitis y la exploración incluyendo la endoscopia nasal y la radiología: TAC y RM.

Las más frecuentes son las orbitarias, celulitis o abscesos, que se manifiestan por edema palpebral, dolor y proptosis, con afectación visual en los casos más graves. Habitualmente unilateral con origen en los senos etmoidales. Si no hay afectación visual o colección purulenta el manejo es conservador, con ingreso hospitalario para terapia antimicrobiana intensiva y control estrecho de la evolución. Los casos más graves se tratan de entrada, o tras una evolución desfavorable, con cirugía endoscópica.

Otra rara, pero grave complicación, es la trombosis del seno cavernoso, por migración retrógrada de la infección desde las venas oftálmicas. En este caso la clínica será también de edema palpebral, proptosis y disminución de la agudeza visual, incluso amaurosis, muchas veces bilateral, junto con síntomas y signos meníngeos.

Para el manejo de estas complicaciones contaremos con el oftalmólogo, que debe hacer un estrecho seguimiento de la visión, y con el neurólogo o el neurocirujano si hay afectación del SNC.

ABSCESO PERIAMIGDALINO

Introducción

Es una colección purulenta retroamigdalina secundaria a una amigdalitis. Suele ser polimicrobiana, pudiendo aislar estreptococos, estafilococos y anaerobios entre otros.

Diagnóstico

Es clínico. Se presenta como un abombamiento del paladar blando y desplazamiento anteromedial de la amígdala. La clínica consiste en disfagia, dolor, fiebre y trismus. Leucocitosis y elevación de la PCR / VSG. En caso de duda podemos recurrir a la ecografía o la TC.

Tratamiento

- **Punción** o incisión evacuadora.

- **Ingreso** para vigilancia y **antibioterapia intravenosa** de amplio espectro y tratamiento sintomático con exploración diaria hasta resolución.
- **Amigdalectomía**: mejor diferida para evitar complicaciones como hemorragia o sepsis. Se debe hacer en casos recidivantes o si hay amigdalitis crónica o de repetición.

ABSCESO RETROFARÍNGEO

Introducción

Colección purulenta, polimicrobiana, entre la pared posterior de la faringe y la fascia prevertebral. Más frecuente en lactantes y niños pequeños.

Diagnóstico

Es clínico. En la exploración encontraremos un abombamiento de la pared posterior de la orofaringe, con fiebre. La técnica más valiosa para confirmación y conocer la extensión es la TC. También la radiografía simple, ecografía o RM pueden ser de ayuda.

Tratamiento

El tratamiento será hospitalario: sin compromiso de la vía aérea antibioterapia intravenosa de amplio espectro, analgésicos y corticoides. Si no evoluciona favorablemente o aparece disnea habrá que optar por la cirugía.

ADENITIS CERVICAL

Inflamación de ganglios linfáticos cervicales con foco infeccioso en área ORL. Suele afectar a los ganglios yugulodigástricos, uní o bilaterales, casi siempre por estafilococos y menos por estreptococos y otros. El tratamiento consiste en un antibiótico oral por 10 días y seguimiento evolutivo. Si no hay resolución en 3 semanas hay que hacer una ecografía y una punción para diagnóstico microbiológico o anatomopatológico, como primeros pasos para esclarecer su origen. Por tanto, una vez pautado el tratamiento dejar pedida una cita con ORL en ese plazo.

COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE LA AMIGDALECTOMÍA

La amigdalectomía es una de las cirugías más frecuentemente practicadas a cualquier edad, pero sobre todo en los niños. Aun actualmente provoca complicaciones graves, con una mortalidad estimada de 1: 15.000. Las más frecuentes son las hemorragias en cualquier momento después de la cirugía, pero con mayor frecuencia en las primeras 24 horas (razón por la que habitualmente la intervención se realiza con ingreso) y hasta varias semanas después, con un pico de incidencia en torno al 10º día por desprendimiento de las placas de fibrina que recubren el lecho quirúrgico. Cualquier hemorragia debe ser considerada de riesgo, debiendo explorarse al niño y ordenando el ingreso si no se aprecia sangrado activo, para observación. Si hay sangrado continuo debe ser revisado quirúrgicamente bajo anestesia general, por tanto es muy importante desde el primer contacto dejar en ayunas con una vía venosa.

COMPLICACIONES DE LA ADENOIDECTOMÍA

También aquí la hemorragia es la más frecuente, que casi siempre requiere revisión quirúrgica pues la causa suele ser una extirpación incompleta que hay que totalizar.

El Síndrome de Grisel o subluxación rotatoria atloaxoidea, lo provoca una técnica quirúrgica inadecuada y es especialmente frecuente en niños con Síndrome de Down. Se manifiesta por

tortícolis con limitación de la movilidad del cuello. El diagnóstico se confirma con una radiografía simple de columna cervical y como tratamiento suele bastar el reposo con un collarín cervical.

TUBOS DE DRENAJE O DE VENTILACIÓN

Ampliamente utilizados en niños de cualquier edad para tratar diferentes tipos de otitis medias. Su finalidad es mantener una miringotomía (perforación timpánica) abierta el tiempo necesario para resolver cualquier forma de otitis, principalmente la otitis media serosa, causada por un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Con ellos mantenemos una ventilación del oído medio evitando que el bloqueo de la trompa mantenga a éste en presión negativa.

Existen muchos tipos de tubos, son de fácil colocación para cualquier cirujano otológico y muy bien tolerados en la mayoría de casos. Sin embargo, en ocasiones dan problemas, casi siempre derivados de un deficiente cuidado postoperatorio, siendo la entrada de agua uno de los principales mecanismos de infección; esta se manifestará por una otorrea purulenta y menos frecuentemente por una otalgia. La consecuencia puede ser la obstrucción del tubo, que perderá su funcionalidad, o la expulsión del mismo antes de haberse resuelto la otitis.

Es por esto que debe tratarse precozmente cualquier otorrea en un oído con un tubo de ventilación, bien con gotas antibióticas, bien con un antibiótico oral de los que utilizamos para las otitis medias, ya que los patógenos suelen ser los mismos, aunque también puede haber *Pseudomonas* y *Candidas*.

Pautado el tratamiento es recomendable remitir en un plazo breve a ORL, por si fuera necesaria una otomicroscopia para repermeabilizarlo, o la retirada del mismo si la infección no cede.

MASTOIDITIS AGUDA

Pese a que el uso de antibióticos en la otitis media ha reducido drásticamente su incidencia, sigue siendo la complicación más frecuente de esta infección en los niños, sobre todo antes de los 3 años.

Es, además, el estadio intermedio hacia graves complicaciones intracraneales como meningoencefalitis, abscesos cerebrales, trombosis del seno cavernoso y otras, por lo que resulta crítico sospecharla y tratarla de forma enérgica y rápida, ya que las demoras diagnósticas suelen ser la causa de dichas complicaciones.

El patógeno más habitual es el neumococo, seguido del estreptococo betahemolítico, *Haemophilus* y *Staph. Aureus*, *Pseudomonas* y no es infrecuente la implicación de cepas resistentes a antibióticos. Es más frecuente en otitis medias no tratadas o con tratamientos incompletos.

Típicamente se manifiesta como una otitis media, actual o reciente, con afectación del estado general, que vuelve a presentar dolor, fiebre y empastamiento retroauricular. En la otoscopia podremos apreciar una otorrea, pero hay casos de mastoiditis larvada o abortada por el uso de antibióticos, en los que el tímpano estará íntegro. La analítica casi invariablemente mostrará una leucocitosis y elevación de la VSG.

Existe una forma bilateral, típica en recién nacidos afectados por otras patologías como malformaciones, inmunosupresión, etc.

El diagnóstico clínico y analítico se completará con estudios de imagen, TC inicialmente y RM en casos graves o con sospecha de complicaciones intracraneales.

El tratamiento inicial es empírico y conservador, con antibióticos de amplio espectro que pasen la BHE, siendo de elección las cefalosporinas de 3ª generación. Antes debe obtenerse una muestra para cultivo, que nos ayudará a ajustar el tratamiento en los días siguientes si la evolución no es satisfactoria. En los casos con tímpano íntegro debe hacerse una miringotomía evacuadora que

permitirá, además, la toma de una muestra bacteriológica y la colocación de un tubo de ventilación, lo que habitualmente acelera la resolución. En los casos más resistentes o complicados, aun hoy se realiza una intervención quirúrgica, la mastoidectomía, que constituía la base del tratamiento hasta la llegada de estos modernos antibióticos.

La prevención es muy importante, tratando adecuadamente cualquier forma de otitis media, y muy especialmente aquellas formas crónicas, persistentes o recidivantes, que están en el origen de muchas de las mastoiditis agudas actualmente.

PARÁLISIS FACIAL

Introducción

La mayoría de las veces idiopática, la llamada parálisis de Bell, de probable origen inmunoinflamatorio, producida por virus herpes y otros, o a reacciones de autoinmunidad.

La parálisis congénita puede ser embriopática o traumática en partos difíciles o instrumentados.

Otras son traumáticas en el contexto de cualquier traumatismo craneofacial, incluidas las yatrogénicas en cirugía otológica o cervicofacial.

Diagnóstico

- **Exploración:** hay que observar y si se puede, estimular la motilidad facial, mejor en posición sentada para observar el efecto de la gravedad, completada con una otoscopia y una exploración de la región parotídea.
En niños mayores puede hacerse una exploración reglada de la motilidad facial, junto con la otoscopia, inspección y palpación cervicofacial y una audiometría tonal; en los más pequeños tendremos que basar el diagnóstico en la observación pasiva, en el reflejo de succión, el llanto o la risa.
- **Exploraciones complementarias:** En casos dudosos pueden ser útiles la TAC y la RMN, así como el análisis audiológico que, en los niños pequeños debe comenzar por una timpanometría, y si hay sospecha de afectación auditiva complementar con PETAC.

Tratamiento

En la parálisis idiopática deben usarse corticoides orales, pese a que la evidencia científica sobre su utilidad no está totalmente asentada. En parálisis secundarias a otras dolencias, además de los corticoides habrá que hacer el tratamiento específico, médico o quirúrgico que esté indicado. El caso más frecuente es la parálisis secundaria a una otitis media, que requerirá un tratamiento antibiótico, o las traumáticas y yatrogénicas en cirugía del oído que suelen precisar revisión quirúrgica.

En todo caso debe prestarse atención al cuidado del ojo afectado para evitar complicaciones por desecación, la más frecuente la queratitis. Cremas hidratantes de uso oftálmico y lágrimas artificiales, junto con oclusión nocturna, suelen ser suficientes. En casos más complejos o de larga duración debemos contar con la ayuda del oftalmólogo.

El pronóstico es bueno en la parálisis idiopática, recuperando la función antes de un mes la mayoría de los casos. Son de peor pronóstico las completas o las que no muestren signos de recuperación en las tres primeras semanas.

Se dan recidivas uní o bilaterales en un 10% de los casos. Las unilaterales deben plantearnos el diagnóstico diferencial con un tumor que comprometa al nervio en cualquier punto de su trayecto intra y extracraneal.

BIBLIOGRAFÍA

- Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 2ª edición, Ed Proyectos médicos.Madrid 2008.
- Tratado de ORL Pediátrica, 1ª edición, Ed Gráficas Alzamora, Girona 2000.
- Urgencias ORL. Ignacio Alvarez Alvarez. Urgencias de 0 a 100 años. J. Navarro Campoamor. Ed. Panamericana Madrid 2017.
- Infecciones en ORL. I Alvarez Alvarez, JP Rodrigo Tapia, J Rodriguez Asensio, M G. Caamaño. Patología Infecciosa en Atención Primaria.ed . J.Navarro Campoamor, Servicio de Salud del Principado de Asturias 2000.